

Какой метод исследования позволяет непосредственно осмотреть слизистую ЖКТ: {

~манометрия

=эндоскопия

~эндосонография

~сцинтиграфия

}

Эндосонография позволяет: {

~установить нарушение функции пищевода

= определить структуру стенки пищевода

~выявить гастроэзофагальный рефлюкс

~определить дискинезию пищевода

}

Что позволяет выявить радионуклидный метод исследования: {

=определить нарушение функции пищевода

~изучить структуру опухоли

~выполнить ряд лечебных мероприятий

~выполнить биопсию

}

Для раннего выявления воспалительных и опухолевых изменений слизистой оболочки применяют метод исследования: {

~сцинтиграфия

~рентгеноскопия

=эндоскопия

~рентгенография

}

Основными методами исследования глотки и пищевода являются: {

~%33.33333% рентгенологический

~%33.33333% эндоскопия

~%33.33333% манометрия

~% - 100% мрт

}

На обычных рентгенограммах пищевод: {

~визуализируется

~не визуализируется

=визуализируется при условии нахождения в нем контрастной массы

~можно визуализировать лишь при эндоскопии

}

При исследовании пищевода водная взвесь сульфата бария применяется : {

=для искусственного контрастирования стенок

~в лечебных целях

~вообще не применяется

~для улучшения продвижения пищевого комка по пищеводу

}

Сколько физиологических сужений у пищевода: {

~1

~3

=4

~2

}

Первое физиологическое сужение обусловлено: {

=вдавлением перстневидно-глоточной мышцы

~вдавлением дуги аорты

~вдавлением грудино-ключично-сосцевидной мышцы

~вдавлением перешейка щитовидной железы

}

Ампула пищевода находится : {

~в средней трети пищевода

=над диафрагмой

~на уровне 7 шейного позвонка

~под диафрагмой

}

Второе физиологическое сужение соответствует: {

~на уровне 7 шейного позвонка

=на уровне дуги аорты

~на уровне правого главного бронха

~на уровне рукоятки грудины

}

Третье физиологическое сужение обусловлено вдавлением образованным: {

=левым главным бронхом

~правым главным бронхом

~нижней поллой веной

~правым предсердием

}

Угол Гиса у здоровых людей составляет: {

~больше 90 град

=меньше 90 град

~ровно 90 град

~меньше 80 град

}

Имеются ли на слизистой пищевода складки: {

~да, имеются циркулярные

=да, имеются продольные

~да, имеются косые

~нет, не имеются

}

Где чаще всего задерживаются инородные тела пищевода: {

=в местах физиологических сужений

~в ампуле пищевода

~в средней трети пищевода
~попадают сразу в желудок
}

Исследование пищевода проводят: {

=натошак
~после плотного приема пищи
~после пробного завтрака
~в любое время
}

Дивертикул представляет собой : {

~мешотчатое выбухание мышечного слоя
=мешотчатое выбухание слизистого и подслизистого слоя
~мешотчатое выбухание адвентициальной оболочки
~мешотчатое выбухание исключительно слизистого слоя
}

Как иначе называют врожденный дивертикул: {

~пульсионный
~тракционный
=ценкеровский
~дивертикулит
}

Дивертикулит это : {

~множественные дивертикулы
=воспаление дивертикула
~прободение дивертикула
~рубцовая деформация дивертикула
}

К дискинезиям пищевода относятся : {

~%33.33333% гипотония
~%33.33333% гиперкинезия
~%33.33333% спазм
~% - 100% Дивертикулез
}

Какие основные типы грыж пищеводного отверстия диафрагмы различают: {

~%33.33333% аксиальные
~% - 50% парааортальные
~%33.33333% параэзофагеальные
~% - 50% Паракардиальные
}

Острый эзофагит наблюдается : {

= при ожоге пищевода
~при травме пищевода
~при гастроэзофагеальном рефлюксе
~при ахалазии пищевода
}

Ахалазия пищевода- это: {

=отсутствие нормального раскрытия кардиального отверстия

~зияние кардиального отверстия

~смещение внутри- и поддиафрагмального сегмента пищевода и части желудка в грудную полость

~рубцовое сужение пищевода

}

Признаки доброкачественных эпителиальных опухолей пищевода: {

~нерезкие контуры дефекта наполнения, прерывистые складки слизистой.

~нерезкие контуры дефекта наполнения, складки слизистой уплощены.

=резкие контуры дефекта наполнения, складки слизистой не прерываются

~контуры дефекта наполнения неровные, складки слизистой прерываются

}

Признаки доброкачественных неэпителиальных опухолей пищевода: {

~неровные контуры дефекта наполнения, складки слизистой прерываются

~волнистые контуры дефекта наполнения, складки слизистой огибают опухоль

~нерезкие контуры дефекта наполнения, складки слизистой разрушены

=ровные контуры дефекта наполнения, складки слизистой сохранены.

}

Признаки злокачественных опухолей пищевода: {

=разрушает складки слизистой, контуры дефекта наполнения нечеткие

~не разрушает складки слизистой, контуры дефекта наполнения четкие

~огибает складки слизистой, контуры дефекта наполнения волнистые

~складки слизистой уплощены, контуры дефекта наполнения ровные

}

Термином дисфагия обозначают: {

=затруднение глотания вследствие различных патологических процессов

~ускорения глотания вследствие различных патологических процессов

~нарушение перистальтики пищевода

~рубцовое сужение пищевода

}

В качестве рентгенконтрастного вещества при рентгеноскопии ЖКТ: {

~применяют РФП

~применяют йодсодержащий контрастный препарат

=применяют сульфат бария

~применяют «пропилийодон»

}

Рельеф внутренней поверхности желудка образуют: {

=складки и ареолы

~циркулярные складки

~продольные складки

~косоидущие складки

}

В желудке выделяют: {

~% - 100% головку тело и хвост

~%33.33333% свод тело и антральный отдел

~%33.33333% кардиальная часть и привратник

~%33.33333% большая и малая кривизна

}

Какие части различают в двенадцатиперстной кишке: {

=верхнюю нисходящую и горизонтальную

~вертикальную горизонтальную и нижнюю

~восходящую боковую и нижнюю

~верхнюю восходящую и вертикальную

}

Какие изгибы различают в двенадцатиперстной кишке: {

=верхний нижний и двенадцатиперстно-тощий

~правый левый и двенадцатиперстно-тощий

~верхний нижний правый и левый

~два боковых и двенадцатиперстно- тощий

}

Время прохождения перистальтической волны от кардиальной части желудка к привратнику составляет около: {

~30 с

~10 с

=20 с

~40 с

}

Точные данные об эвакуации содержимого из желудка позволяет получить

~манометрия: {

~узи желудка

~перфузионная сцинтиграфия

=динамическая сцинтиграфия

}

Меккелев дивертикул располагается: {

=в дистальном отделе двенадцатиперстной кишки

~в дистальной части пищевода

~в кардиальной части желудка

~проксимальной части двенадцатиперстной кишки

}

Рентгенпризнаки хронического гастрита: {

~%33.33333% грубонодулярный тип тонкого рельефа

~%33.33333% складки выпрямлены или извиты с эрозиями

~%33.33333% ареолы свыше 5мм

~% - 100% ареолы 1-3мм

}

В период обострения хронического гастрита: {

~желудок не содержит жидкости и перистальтика ослаблена

=желудок содержит жидкость и перистальтика усилена

~тонус желудка понижен перистальтика ослаблена
+тонус желудка повышен, спазм антрального отдела
}

В период ремиссии хронического гастрита: {
~желудок не содержит жидкости и перистальтика ослаблена
~желудок содержит жидкость и перистальтика усилена
=тонус желудка понижен перистальтика ослаблена
~тонус желудка повышен, спазм антрального отдела
}

Прямые рентгенпризнаки язвы желудка: {
=язвенная ниша
~наличие жидкости натошак
~регионарный спазм
~симптом местной гиперкинезии
}

Косвенные рентгенпризнаки язвы желудка: {
~% - 100% Язвенная ниша
~%33.33333% наличие жидкости натошак
~%33.33333% регионарный спазм
~%33.33333% симптом местной гиперкинезии
}

В стадии обострения язвенной болезни наблюдается: {
~%50% увеличение ниши
~% - 50% сужение воспалительного вала вокруг ниши
~%50% расширение воспалительного вала вокруг ниши
~% - 50% уменьшение ниши или его исчезновение
}

В стадии ремиссии язвенной болезни наблюдается: {
~% - 50% увеличение ниши
~% 50% нормализация функции желудка
~% - 50% расширение воспалительного вала вокруг ниши
~% 50% уменьшение ниши или его исчезновение
}

Дивертикул желудка имеет: {
~%50% правильную форму, ровные контуры, хорошо сформированную шейку
~%50% складки не изменены, входят в дивертикул через шейку
~% - 50% неровные очертания, остроконечную форму с скоплением в центре контрастной массы
~% - 50% бесструктурный ободок, конвергированные складки вокруг
}

Рентгенпризнаки прободения язвы: {
=наличие свободного газа в брюшной полости
~кровоотечение
~перитонит

~симптом указующего перста

}

Рентгенпризнаки рака желудка: {

~%33.33333% ниша неправильной формы

~%33.33333% сходящиеся к нише складки

~% - 100% усиленная перистальтика в области инфильтрата

~%33.33333% отсутствие перистальтики в области инфильтрата

}

Складки слизистой пищевода лучше выявляются: {

~при тугом заполнении барием

=после прохождения бариевого комка, при частичном спадении просвета

~при двойном контрастировании

~при использовании релаксантов

}

Состояние перистальтики пищевода можно оценить объективно с помощью:

{

~рентгеноскопии

~рентгенографии

~функциональных проб

=рентгенокинематографии (видеозаписи)

}

Для релаксации желудочно-кишечного тракта применяют: {

~морфин

~пилокарпин

~прозерпин, ациклидин

=атропин, метацин, аэрон

}

Преимущества энтероклизмы перед другими методиками

рентгенологического исследования тонкой кишки состоит в том, что она: {

~не дает осложнений, не имеет противопоказаний

~позволяет изучить функциональные нарушения

~позволяет оценить сроки пассажа бария по кишке

=позволяет выявить участки сужения, их протяженность, сокращает продолжительность исследования

}

Контрастирование желчного пузыря при пероральной холецистографии происходит: {

=за счет способности организма выделять в составе желчи принятое

контрастное вещество и возможности желчного пузыря концентрировать контрастированную желчь

~за счет выделения контрастного вещества стенкой пузыря

~за счет избирательной абсорбции белка из контрастированной желчи

~за счет сочетания названных процессов

}

Одиночная известковой плотности тень неправильной формы до 1 см в правой верхней половине живота, располагающаяся в боковой проекции кпереди от позвоночника, обусловлена: {

=камнем желчного пузыря или общего желчного протока

~почечным камнем

~обызвествленным лимфоузлом

~обызвествлением в головке поджелудочной железы

}

Складки слизистой антрального отдела желудка являются результатом деятельности мышечного слоя. Нормальным для них направлением является:

{

~продольное

~поперечное

~косое

=любое из перечисленных в зависимости от фазы моторики

}

Складки слизистой лучше выражены: {

~в тощей кишке

~в подвздошной кишке

~в двенадцатиперстной кишке

=в тощей и двенадцатиперстной кишке

}

Ведущим рентгенологическим симптомом атрезии пищевода является: {

~сужение пищевода

=наличие слепого мешка

~деформация пищевода

~расширение пищевода

}

Термин - "штопорообразный пищевод" отражает: {

~аномалию развития

~порок развития

=нейромышечное заболевание

}

Газовый пузырь желудка при ахалазии III-IV степени: {

~деформирован

~отсутствует

~уменьшен

~увеличен

=уменьшен или отсутствует

}

При химических ожогах пищевода рубцовое сужение просвета чаще наблюдается: {

~в верхней трети

~в средней трети

~в дистальной трети

=в местах физиологических сужений

}

Рубцовые изменения пищевода с укорочением его дистального отдела и фиксированная грыжа пищеводного отверстия диафрагмы являются чаще всего следствием: {

~диабета

~ахалазии кардии

=язвенного рефлюкс-эзофагита

~резекции желудка

}

Варикоз вен пищевода выражается: {

~"разлохмаченным" контуром в средней и нижней трети грудного отдела пищевода. Могут наблюдаться изъязвления

=дефекты имеют вид серпантина, меняют величину и форму в зависимости от положения больного, фазы дыхания и локализуются в средней и нижней трети пищевода

~наиболее частой локализацией в нижней трети пищевода и обычно сочетается с грыжей пищеводного отверстия диафрагмы

}

Наиболее сходную рентгенологическую картину дают следующие заболевания пищевода

~варикозное расширение вен и рак: {

~чашеподобная карцинома и язва

=стенозирующий кардио-эзофагеальный рак и кардиоспазм

}

Плоское инородное тело (монета) в верхнем отделе пищевода располагается:

{

~горизонтально

~в сагитальной плоскости

=во фронтальной плоскости

~косо

}

Желудок увеличен в размерах с жидкостью натошак. Малая кривизна антрального отдела укорочена, пилоро-дуоденальная область гипермотильная, привратник сужен, асимметричен, луковица двенадцатиперстной кишки деформирована. Опорожнение желудка замедленное. Эти симптомы характерны: {

~для эндофитного рака

=для рубцово-язвенного стеноза привратника

~для антрального ригидного гастрита

~для врожденного пилоростеноза

}

У больного с механической желтухой в нисходящем отделе двенадцатиперстной кишки определяется дефект наполнения размерами

2 2.5 см неправильной формы, кишка раздражена. Эти симптомы характерны: {

~для саркомы

=для рака большого дуоденального соска

~для лейомиомы

~для полипа

}

Петля двенадцатиперстной кишки развернута, ее медиальный контур деформирован, ригидный, имеется симптом полутени (кулис) и признаки разрушения слизистой. Ваше заключение: {

~панкреатит

=рак головки поджелудочной железы

~дуоденит

~перидуоденит

}

Многочисленные округлые дефекты наполнения ободочной кишки с четкими контурами на фоне неизменной слизистой характерны: {

~для рака

~для дивертикулеза

=для множественных (групповых) полипов

~для болезни Крона

}

Одиночный округлый дефект наполнения в толстой кишке с бугристой поверхностью размерами более 3 см - это рентгенологические признаки: {

~дивертикула

=экзофитного рака

~полипа

~эндофитного рака

}

Цирроз печени характеризуется диффузным или очаговым увеличением количества: {

~желчных протоков

=соединительной ткани

~печеночных клеток

~сосудистых элементов

}

Округлый краевой дефект наполнения контрастированного желчного пузыря 1.5x2 см, не меняющий своего положения в различных проекциях, является симптомом: {

~конкремента

~перихолецистита

=доброкачественной опухоли

~рака

}

Абдоминальная часть пищевода и верхняя часть желудка при рентгенологическом исследовании пациента в горизонтальном положении находятся выше диафрагмы, пищевод перед впадением в желудок образует изгибы. Такая картина характерна: {
~для параэзофагеальной грыжи пищеводного отверстия
=для аксиальной кардио-фундальной нефиксированной грыжи пищеводного отверстия
~для релаксации диафрагмы
~для парастеральной грыжи
}

Для любого вида механической кишечной непроходимости общими рентгенологическими признаками являются: {
~свободный газ в брюшной полости
~свободная жидкость в брюшной полости
=арки и горизонтальные уровни жидкости в кишечнике
~нарушение топографии желудочно-кишечного тракта
}

На рентгенограммах брюшной полости видны вздутые газом кишечные петли, в которых при вертикальном положении больного определяется жидкость с горизонтальными уровнями. Такая картина характерна: {
~для закрытой травмы живота
~для разрыва стенки кишки
=для механической кишечной непроходимости
~для хронического аппендицита
}

Определяющим рентгенологическим признаком выраженной механической непроходимости тонкой кишки и правой половины ободочной кишки является выявление: {
=горизонтальных уровней жидкости, ширина которых больше высоты газа над ними
~горизонтальных уровней жидкости, ширина которых меньше высоты газа над ними
~скопления газа в тонкой кишке
~большого количества газа в тонкой и толстой кишках
}

В основе дифференциальной рентгенодиагностики функциональной и механической кишечной непроходимости имеет значение: {
~локализация уровня непроходимости
~обнаружение асцита
~соотношение газа и жидкости в кишечнике, локальность или распространенность изменений
=медленное изменение положения кишечных петель при изменении положения тела исследуемого, ограничение подвижности диафрагмы
}

Наиболее достоверными ультразвуковыми признаками желчных камней являются: {

=гиперэхогенные образования с акустической тенью, перемещающиеся при перемене положения больного

~гиперэхогенное образование без акустической тени

~пристеночное гиперэхогенное образование, не смещающееся при перемене положения тела больного

~образование неоднородной структуры без акустической тени

}